Plan de Expansión HPTU

Sede Ambulatoria — Localización Estratégica

MCDA 5 dimensiones · 3.8M+ registros · 15 fuentes oficiales

6 zonas evaluadas · Foco ambulatorio · Sin urgencias, sin alta complejidad

Actualizado con feedback de Junta Directiva — 16 de marzo

Junta Directiva · Abril 2026

básica

Agenda — 1 hora, 6 actos

5 min	**Acto 1** El Plan de Expansión — contexto, escala, qué cambió
10 min	**Acto 2** El Mercado Dual — El Poblado (174K predios) + Oriente (728K hab)
10 min	**Acto 3** Los Fundamentales del Oriente — estratos, brechas, Túnel
12 min	**Acto 4** Las 6 Preguntas — tiempos post-Túnel, turismo médico
15 min	**Acto 5** El Modelo — MCDA 5 dims, concepto ambulatorio, financiero
8 min	**Acto 6** Siguiente Paso — cronograma, Q&A

Dashboard interactivo: `https://hptu-localizacion.vercel.app`

Lo que cambió desde la Junta del 16 de marzo

Feedback de la Junta

1. **Nombre:** “Nueva Sede” → **Plan de Expansión**
2. **Foco:** Ambulatorio, **sin urgencias ni alta complejidad**
3. **SVF:** Faltaba en tabla — es **duopolio Somer + SVF**
4. **MCDA:** Reemplazar “Valor Inmobiliario” con **Visibilidad + Esperas Productivas**
5. **Estratos:** ¿Cuántos son E4/5/6 de los 728K?
6. **Conceptos:** Cleveland Clinic, PRENUVO, wellness

Lo que se hizo

- ✓ **5 dimensiones MCDA** (Acc 30%, Dem 25%, Comp 20%, Vis 15%, Esp 10%)
- ✓ SVF en todas las tablas de brechas
- ✓ Proxy estratos Oriente (Decreto 096/2021 Rionegro)
- ✓ Portafolio ambulatorio (7 categorías, sin urgencias/UCI)
- ✓ Modelo financiero ambulatorio ($67,000M)
- ✓ Tiempos post-Túnel 2da etapa
- ✓ Referentes: Cleveland Clinic, PRENUVO, CEDIMED

Los seis ajustes, en detalle

1. **Nombre → Plan de Expansión.** Esto no es un hospital nuevo. Es la expansión ambulatoria de HPTU — herencia de marca, mismos protocolos, mismos especialistas.
2. **Foco ambulatorio.** Siete categorías de servicio: imágenes, consulta, cirugía de día, chequeo ejecutivo, rehabilitación, estética y oncología ambulatoria. **Cero camas, cero urgencias, cero UCI.**
3. **Duopolio Somer + SVF.** San Vicente Fundación Rionegro tiene oncología, radioterapia, cirugía y pediatría subespecializada. Toda la presentación refleja que es un **duopolio**. Nuestra propuesta ambulatoria **complementa** a ambos, no compite.
4. **MCDA: Visibilidad + Esperas Productivas.** No compramos terreno — arrendamos en Access Point. El valor inmobiliario es irrelevante. Lo que importa: cuánta gente nos ve (**42K veh/día**) y qué ecosistema hay alrededor.
5. **Estratos Oriente.** Solo Rionegro tiene dato directo (Decreto 096/2021): **42%** de viviendas son E4+. Para los demás municipios: proxy conservador basado en afiliación contributiva. Somos transparentes sobre las limitaciones.
6. **Referentes internacionales.** Cleveland Clinic: 270 centros ambulatorios satélite. PRENUVO: MRI preventivo como diferenciador premium. CEDIMED: valida el modelo de imágenes pero no tiene presencia en el Oriente.

La escala del análisis

Datos procesados

Fuentes primarias	**15**
Registros procesados	**3.8M+**
Zonas evaluadas	**6**
Dimensiones MCDA	**5**
Competidores perfilados	**13**
Barrios analizados	**22**
Municipios Oriente	**11**
Periodo de datos	2017–2037

Modelo MCDA (score 0–100)

5 dimensiones, pesos confirmados post-Junta:

$$\text{Score} = \underbrace{A \times 30\%}_{\text{Acc.}} + \underbrace{D \times 25\%}_{\text{Dem.}} + \underbrace{C \times 20\%}_{\text{Comp.}} + \underbrace{\text{Vis} \times 15\%}_{\text{Visib.}} + \underbrace{\text{Esp} \times 10\%}_{\text{Esperas}}$$

Nuevas variables:

- **Visibilidad:** tráfico vehicular, exposición
- **Esperas Productivas:** retail/servicios en 500m

Validado con **Monte Carlo** (3,000 iter., 6 escenarios).

Fuente: Catastro, REPS, MEData Aforos, DANE, POT, ANI, Mapbox, Google Places, OSM

Medellín Metropolitano: el mercado principal

Municipio	2018	2026	Crec.
Medellín	2,327,880	2,471,274	+6.1%
Envigado	210,705	246,874	+17.1%
Itagüí	240,828	256,679	+6.6%
Sabaneta	73,838	87,879	**+19.0%**
Total metro	**2,853,251**	**3,062,706**	+7.3%
El Poblado	134,873	163,578	+21.2%

Fuente: DANE CNPV 2018, DENSURBAM proyecciones tendenciales

El mercado premium

Predios E5/E6 corredor	**174,543**
Predios E6 (El Poblado)	38,415
Avalúo promedio E6	$437.8M COP
Afiliados prepagada SURA	320,000
Prepagada Antioquia	**1.4M afiliados**
Revenue prepagada/año	**COP $7,2 billones**
Crecimiento 2022-25	+37%

Proyección 2037

Valle de Aburrá: **+152K personas**
El Poblado: **180,314 hab** (+20.6%)
Sabaneta: +19.0% · Envigado: +17.1%

Déficit de salud: 0.54 camas por 1,000 habitantes

Municipio	Camas/1000	OMS mín.	Déficit
Medellín	1.0	3.0	–6
Envigado	0.6	3.0	–8
Itagüí	0.6	3.0	–8
Sabaneta	0.5	3.0	–8
Corredor Las Palmas	0.0	3.0	**–1**

Corredor Las Palmas al 2037

Habitantes sin cobertura	103,913
Oferta actual (m²/hab)	0.0
Estándar requerido	3.5 m²/hab
m² equipamiento necesario	**363,696**

Con crecimiento de **+20.6%** al 2037, la brecha solo se ampliará. **La sede ambulatoria HPTU cerraría directamente este déficit.**

DENSURBAM confirma

IRS Salud El Poblado: **0.27** (umbral: 2.5)
5 veces por debajo del mínimo de sostenibilidad.
10 barrios con **0.0 m²** de oferta de salud.

Hospitales más cercanos al corredor

Cl. Rosario Tesoro	158 camas	**0.93 km**
Cl. Las Vegas	171 camas	3.12 km
Cl. CES	213 camas	7.16 km

Sin alta complej.

Fuente: REPS (s2ru-bqt6), DENSURBAM (URBAM-EAFIT/AMVA), DANE proyecciones

Mercado 1: El Poblado — 174,543 predios E5/E6

Barrio	E5/E6	%	Avalúo
El Poblado core	**38,415**	**98**	$371M
Castropol	6,228	97	$327M
Los Balsos No. 1	4,019	95	$401M
San Lucas	3,671	93	$512M
Manila	2,144	96	$305M
Altos del Poblado	1,867	91	$245M
+ 15 barrios más			
Total 22 barrios	**174,543**		

Fuente: Catastro Medellín (bp59-rj8r)

Corredor Las Palmas

- **42,000 veh/día** en Av. Las Palmas (MEData)
- **0 camas** de alta complejidad en el corredor
- POT permite hasta **19 pisos** en San Lucas
- Solo **45.8%** de densidad usada
- 103,913 hab. sin cobertura a 2037 (DENSURBAM)

Brecha

174K predios E5/E6
a >20 min de HPTU Robledo

básica

Mercado 2: Oriente Antioqueño — 728,000 habitantes

Municipio	Pob. 2018	% Contrib.
Rionegro	116,400	**54.9%**
Marinilla	56,399	41.1%
La Ceja	53,134	**51.4%**
Guarne	52,570	42.9%
El Carmen	48,988	31.5%
El Retiro	19,695	**56.8%**
+ 5 municipios		
Total Oriente	**728,581**	**42.8%**

Fuente: DANE CNPV 2018, RUAF Aseguramiento

Infraestructura de salud: duopolio

Alta complejidad en Oriente:

- **Cl. Somer** — oncología (UFCA), radioterapia, trasplante cardíaco
- **SVF Rionegro** — oncología, cirugía, pediatría sub., va a 500 camas

Duopolio, no monopolio.
Oportunidad: ambulatorio especializado que complementa, no compite.

Crecimiento: +1.64%/año, migración 5.2/100 hab, PIB 10.4% de Antioquia

básica

Dato faltante: ¿Cuántos son estrato 4/5/6 en el Oriente?

Dato directo: solo Rionegro

Estrato	Viviendas	%
E1	1,879	4.2%
E2	7,221	16.1%
E3	16,853	37.6%
E4	**15,633**	**34.9%**
E5	2,723	6.1%
E6	496	1.1%
Total	**44,805**	
E4+	**18,852**	**42.1%**

Fuente: Decreto 096/2021 Rionegro, DiariOriente

Proxy para otros municipios

No existe dataset directo en datos.gov.co.

Método: ratio E4+/contributivo de Rionegro (0.765) aplicado a % contributivo de cada municipio.

Municipio	E4+ est.
Rionegro (directo)	**18,852**
La Ceja	7,222
Marinilla	6,143
Guarne	5,929
El Carmen	4,078
El Retiro	2,909
+ 5 municipios	
Total Oriente	**~53,800**

Transparencia: estimación conservadora. Solo Rionegro tiene dato directo. Proxy asume relación estrato-régimen similar entre municipios.

Brechas ambulatorias en el Oriente (actualizado con SVF)

Servicio	Status Oriente	Nivel	Oportunidad HPTU
Cirugía Ambulatoria	Campestre + SVF (limitada)	Limitado	Hub quirúrgico: ortop., urología, ORL
Imágenes Avanzadas	IMEDI + Somer (limitado)	Limitado	Centro TAC, RMN, PET-CT (Fase 2), PRENUVO
Oncología Ambulatoria	Somer y SVF (duopolio)	Limitado	QT ambulatoria, 2da opinión
Radioterapia	Somer y SVF (duopolio)	Limitado	3er centro si demanda lo justifica
Rehabilitación Esp.	Básica únicamente	**Inexist.**	Neuro, cardíaca, deportiva
Chequeo Ejecutivo	Inexistente	**Inexist.**	Premium: Zona Franca + aeropuerto
Turismo Médico	SVF (incipiente)	Limitado	23,323 pac int./año, cerca aeropuerto
Pediatría Sub.	SVF Rionegro (limitada)	Limitado	Ampliar cobertura ambulatoria

Corrección post-Junta

SVF Rionegro tiene: oncología, radioterapia, cirugía amb., pediatría sub., turismo médico. Es **duopolio Somer + SVF**.

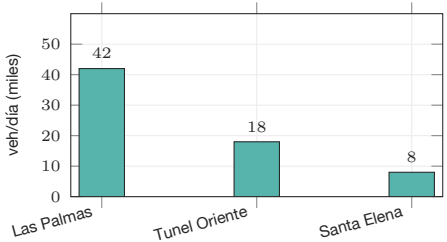
Oportunidad HPTU

Sede ambulatoria **no compite** con Somer ni SVF en alta complejidad. **Complementa** con servicios que hoy requieren referencia a Medellín.

Fuente: REPS (b4dp-ximh), Google Places, Junta Directiva 16 marzo

42,000 vehículos/día en Vía Las Palmas

Corredores de acceso al Oriente:



Fuente: MEData Aforos (b9s9-jw7c), 64,285 obs.

Access Point = máxima visibilidad

- Km 7 Vía Las Palmas, Retorno 5
- **Todo vehículo al Túnel pasa por Km 7**
- Sin pico y placa
- 2da etapa Túnel (H2 2027): **tráfico se duplica**
- Score Visibilidad: **78/100**

Velocidad por hora

	Las Palmas	Poblado
AM (8:00)	40.9 km/h	22.5 km/h
PM (17:00)	36.1 km/h	**18.0 km/h**

Nota: Tráfico genera reconocimiento de marca. Demanda médica se genera por referencia médica y contratos EPS.

básica

2da Etapa Túnel de Oriente: el game changer (H2 2027)

El proyecto

Inversión	COP $1.8 billones
Avance	19% (mar 2026)
Túnel Santa Elena 2	8.2 km excavado
Entrega	H2 2027
Impacto	Doble calzada completa

Access Point en Km 7 = **nodo de entrada** a la doble calzada.

Impacto en tiempos de viaje

Destino	Hoy	Post-Túnel
Aeropuerto SKRG	51 min	**∼25 min**
El Retiro	44 min	**∼28 min**
Rionegro	59 min	∼38 min
Marinilla	67 min	∼43 min
La Ceja	65 min	∼42 min

Infraestructura complementaria

- **Intercambio Alto Palmas** ($18,000M) — elimina congestión
- **Vía Aeropuerto-Belén** ($120,000M) — acorta 12 km
- **Vía Llanogrande-Cañada** ($120,000M) — La Ceja a 10 min
- **Tren Ligero Rionegro** — anulado (8-10 años)

Aeropuerto JMC: Plan Maestro 2055

14.5M → **42.7M pasajeros**

COP $22 billones · A **∼25 min** de AP post-Túnel

Infraestructura de salud del Oriente: concentrada y crítica

Municipio	Camas	/1000	Gap OMS
Rionegro	656	4.86	—
La Ceja	240	3.48	—
Guarne	184	3.73	—
El Carmen	37	**0.59**	+1.91
Marinilla	27	**0.42**	+2.08
El Retiro	26	**1.08**	+1.42
El Santuario	6	**0.17**	+2.33
Total Oriente	**1,199**		

Fuente: REPS capacidad instalada (b4dp-ximh), DANE est. 2026

3 datos críticos

1. **55%** de camas concentradas en Rionegro
2. **Duopolio Somer + SVF** en alta complejidad
3. **4 municipios** con <1 cama/1000 hab

Oportunidad ambulatoria

La brecha no es de camas (Somer y SVF lo cubren). La brecha es de **servicios ambulatorios especializados**: imágenes, rehabilitación, chequeo ejecutivo, cirugía de día.

8 de 8 indicadores apuntan al Oriente

#	Indicador	Valor	Tendencia
1	Población Oriente (DANE)	728,581	↑ +1.64%/año
2	Tráfico Las Palmas (MEData)	42,000 veh/día	↑ +89% en 10 años
3	Pasajeros aeropuerto (Aerocivil)	14.5M → 42.7M	↑ Plan Maestro 2055
4	Prepagada Antioquia (SURA)	1.4M afiliados	↑ +37% (2022-25)
5	Contributivos Oriente (RUAF)	384,171	↑ ratio C/S = 3.46×
6	Zona Franca empresas	300 + 12K emp.	↑ expansión
7	Inversión infraestructura vial	COP $2+ billones	↑ 5 proyectos
8	Cirugía ambulatoria Colombia	490,944 proc/año	↑ +10% YoY

8 de 8 indicadores son crecientes.

La demanda no va a disminuir.

Fuente: DANE, MEData, Aerocivil, SURA, RUAF, MinSalud

Demanda capturable: 45,000 consultas/año desde el Oriente

Oriente: 298K hab
5 mun. <45 min

↓

~218K/año
requieren atención esp.

↓

~65K viajan a Medellín
30% de la demanda

↓

Access Point intercepta
45K consultas/año

Fuente: BDUA marzo 2026 (ADRES), RUAF Aseguramiento

Mercado contributivo por municipio

	Contrib.	>50%?
Rionegro	161,041	**Sí**
El Retiro	10,845	**Sí**
La Ceja	26,920	**Sí**
Guarne	22,100	No
Marinilla	22,900	No
Total	**384,171**	

3 municipios con >50% contributivo = **mercado privado fuerte**. SURA domina 64-79%.

6 preguntas, 6 respuestas: todas Sí

Q1 ✓
¿Hay pacientes?
728K hab
Oriente desatendido

Q2 ✓
¿Vendrán a Km 7?
~25 min
post-Túnel al Oriente

Q3 ✓
¿Pueden pagar?
384K contrib.
ratio C/S 3.46

Q4 ✓
¿Crecerá la demanda?
8 de 8 ↑
indicadores up

Q5 ✓
¿Otros validaron?
$590,000M
6 instituciones

Q6 ✓
¿Turismo de salud?
USD $11.7M
captura 5%

Tiempos actualizados con estimaciones post-Túnel 2da etapa (H2 2027).

Preguntas 1–3: Pacientes, Acceso, Capacidad de Pago

Q1: ¿Hay pacientes?

- HPTU Robledo: **540 camas**, saturado
- Corredor Las Palmas: **0 camas** alta complej.
- Oriente: 728K hab con **4 municipios** $<$**1 cama/1000**
- DENSURBAM: 103,913 hab sin cobertura a 2037

Sí. Demanda masiva.

Q2: ¿Vendrán a Km 7?

- Access Point $\rightarrow$ El Retiro: $\sim$**28 min** post-Túnel (hoy 44)
- AP $\rightarrow$ Aeropuerto: $\sim$**25 min** post-Túnel (hoy 51)
- AP $\rightarrow$ Rionegro: $\sim$38 min post-Túnel (hoy 59)
- Sin pico y placa

Sí. $-$36% tiempos.

Q3: ¿Pueden pagar?

- **384K contributivos** Oriente
- Ratio C/S: **3.46**$\times$
- SURA: 64–79% del mercado
- Rionegro: 55% contributivo
- Prepagada: +37% en 3 años

Sí. Mercado solvente.

Fuente: REPS, DENSURBAM, Mapbox Matrix, BDUA, RUAF, SURA

Preguntas 4–6: Crecimiento, Validación, Turismo Médico

Q4: ¿Crecerá la demanda?

- Población: +1.64%/año
- Tráfico: +89% en 10 años
- Aeropuerto: 14.5M $\rightarrow$ 42.7M
- Prepagada: +37%
- Cirugía amb.: +10% YoY

Sí. 8 de 8 ↑

Q5: ¿Otros validaron?

Inversión combinada competidores:

- Campestre Rionegro: $30,000M
- SVF expansión: $>$$200,000M
- Torre Oviedo: $100,000M
- AUNA Sur: $90,000M
- H. San Juan Dios: $130,000M

Sí. $590,000M invertidos.

Q6: ¿Turismo de salud?

- 23,323 pac int./año en Medellín
- **0 instituciones JCI** a $<$30 min del aeropuerto
- HPTU: único JCI en Antioquia
- AP post-Túnel: $\sim$25 min a SKRG
- Captura 5% = **USD $11.7M/año**

Sí. USD $11.7M.

Fuente: DANE, MEData, Aerocivil, REPS, ProColombia, JCI Directory

Nuevo MCDA: 5 dimensiones (vs 4 de marzo)

Fórmula actualizada

$$\text{Score} = A \times 30\% + D \times 25\% + C \times 20\% + \text{Vis} \times 15\% + \text{Esp} \times 10\%$$

Variable	Peso	Proxy
Accesibilidad	30%	Isócronas, tiempos
Demanda	25%	Población, contributivos
Competencia	20%	Densidad IPS, brechas
Visibilidad	**15%**	Tráfico veh., exposición
Esperas Prod.	**10%**	Retail/servicios 500m

Cambio vs marzo

Se **reemplaza** "Valor Inmobiliario" (15%) con:

- **Visibilidad (15%):** tráfico vehicular diario, exposición desde vía principal
- **Esperas Productivas (10%):** retail, cafeterías, farmacias en 500m

¿Por qué? El Plan de Expansión no compra terreno — arrienda en Access Point. El valor inmobiliario es irrelevante; la visibilidad y el ecosistema alrededor sí importan.

Nota metodológica: Los scores involucran juicio analítico. Monte Carlo valida estabilidad del ranking ante cambios de pesos, no la exactitud de los scores de entrada.

Ranking MCDA: Access Point #2 (78/100)

Zona	Score	Acc (30)	Dem (25)	Comp (20)	Vis (15)	Esp (10)
1. Las Palmas Bajo	**88**	92	93	78	85	88
2. Access Point	**78**	85	91	65	**78**	55
3. Las Palmas Medio	76	72	84	82	70	65
4. Envigado	74	75	80	62	78	72
5. Nuevo Poblado	70	82	68	52	80	55
6. Las Palmas Alto	50	42	52	90	30	20

Access Point: fortalezas

- **Visibilidad 78** — 42K veh/día, todo tráfico al Túnel
- **Demanda 91** — captación dual: Poblado + Oriente + aeropuerto
- **Accesibilidad 85** — 18.5 min a HPTU, ∼25' a aeropuerto post-Túnel

¿Por qué AP si LP Bajo es #1?

- LP Bajo = mejor greenfield, pero lote + diseño + licencias + construcción = **54+ meses**
- AP = edificio existe: negociación + fit-out = **18–24 meses**
- Monte Carlo: AP **top-2** en >78% de simulaciones

Nota: Scores involucran juicio analítico. Monte Carlo valida estabilidad del ranking, no exactitud de scores de entrada.

Concepto: Sede Ambulatoria — Modelo Cleveland Clinic

El modelo

Cleveland Clinic opera **270+ ubicaciones ambulatorias** fuera de su campus principal. Cada satélite hereda: marca, protocolos, especialistas.

Revenue ambulatorio: USD $6.800M / $15.700M total (>43%)

La analogía HPTU:
El paciente del Oriente recibe **calidad HPTU** en Access Point — a 18 min de Robledo, sin ir al campus.

Heritage de marca: lo ambulatorio hereda el poder de HPTU.

Lo que SÍ incluye

1. Imágenes: TAC, RMN 3T, PET-CT (Fase 2), **PRENUVO**
2. Consulta especializada ambulatoria
3. Cirugía ambulatoria (4 quirófanos)
4. Chequeo ejecutivo / wellness
5. Rehabilitación especializada
6. Estética / dermatología
7. Oncología ambulatoria (QT, 2da opinión)

Lo que NO incluye

Urgencias · **Hospitalización** · **UCI** · **Trasplantes** · **Alta complejidad** — No compite con Somer ni SVF.

Diferenciador: Full-Body MRI Preventivo (PRENUVO)

¿Qué es?

Escaneo de resonancia magnética de cuerpo completo (∼60 min, sin radiación) para detección temprana.

Precio (EE.UU.)	USD $1,800–$2,499
Duración	∼60 minutos
Centros globales	18 (EE.UU., UK, Canadá)
Wait list	3–6 meses
Revenue est. 2024	>USD $200M

Fuente: PRENUVO.com, Forbes, Bloomberg 2024

Target en Antioquia

- **300 empresas Zona Franca** (12,000 empleados)
- Viajeros frecuentes aeropuerto
- Residentes E5/E6 El Poblado y Oriente
- Turismo médico (23,323 pac int./año)

Ningún competidor en Antioquia ofrece este servicio.

Diferenciador único.

Competencia en imágenes: CEDIMED no está en el Oriente

CEDIMED — referente en Antioquia

Fundación	1990 (35+ añ
Sedes	Poblado, San Diego, Oviedo, Enviga
Servicios	RMN, TAC, PET-CT (Fase 2), mamogra
Convenios	Múltiples EPS y prepagac
Oriente	**Sin presen**

CEDIMED valida que los centros de imágenes satélite (fuera del campus hospitalario) **son rentables** en Antioquia.

Oportunidad para HPTU

- CEDIMED **no tiene presencia en el Oriente**
- IMEDI y Somer: imágenes limitadas
- Nadie ofrece **PET-CT** ni full-body MRI en el corredor
- HPTU + PRENUVO: **diferenciador único**
- Revenue imágenes: **COP $15,000M/año**

Ventaja HPTU vs CEDIMED

CEDIMED = solo imágenes.
HPTU = imágenes + consulta + cirugía + wellness.
Portafolio integrado.

Fuente: CEDIMED.com.co, Torre Médica Oviedo comunicado 2025

Modelo financiero: sede ambulatoria en Access Point

Inversión

Item	COP
Fit-out médico (6,000 m²)	$21,000M
Equipos (MRI 3T, CT, quirófanos)	$31,000M
IT + mobiliario	$5,000M
Capital de trabajo (12 meses)	$10,000M
Total CAPEX	**$67,000M**

Fase 2: PET-CT & $14,000M (cuando volumen oncológico lo justifique)

Ventaja Access Point: edificio existente (4 torres). No hay costo de construcción ni terreno — solo fit-out y equipamiento. **18–24 meses** para abrir.

Revenue (año maduro)

Línea	COP/año
Imágenes (TAC, RMN)	$15,000M
Cirugía ambulatoria (4 ORs)	$14,000M
Consultas (∼40K/año)	$8,000M
Chequeo ejecutivo / wellness	$6,000M
Rehab + oncología amb.	$5,000M
Estética / derma	$3,000M
Total revenue	**$51,000M**
EBITDA (18%)	**$9,200M**

Ramp-up: Y1=40%, Y2=65%, Y3=85%, Y4+=100%

3 escenarios: Pesimista (70% rev, 15% EBITDA): payback ∼12 a. · **Base** (100%, 18%): payback ∼7 a. · Optimista (+PET-CT Fase 2, 22%): payback ∼5 a.

básica

Esperas Productivas: el modelo wellness center

Concepto

Transformar el tiempo de espera del paciente en una **experiencia positiva**.

El entorno del centro ambulatorio incluye retail, cafeterías, farmacias que generan revenue adicional y mejoran la experiencia.

Referentes

- **Cleveland Clinic:** cafeterías, farmacias, retail en cada ambulatory center
- **Torre Médica Oviedo:** dentro de CC Oviedo — esperas productivas naturales
- **Access Point:** 4 torres de oficinas con retail potencial en primeros pisos

Scores por zona

Zona	Visibilidad	Esperas
Access Point	**78**	55
Las Palmas Bajo	85	**88**
Nuevo Poblado	80	55
Envigado	78	72
Las Palmas Medio	70	65
Las Palmas Alto	30	20

Visibilidad: tráfico vehicular + exposición desde vía.

Esperas: densidad retail/servicios en radio 500m.

Access Point tiene visibilidad **máxima** (42K veh/día) y potencial de desarrollo como anchor hospital.

Access Point — Km 7 Vía Las Palmas, Retorno 5

Ficha técnica

Proyecto	Acierto Inmobiliario
Torres	4 × 10 pisos
Parqueaderos	1,085 (477 vis. + 608 priv.)
Score MCDA	**78/100 (#2)**
A HPTU Robledo	18.5 min (Mapbox)
Al Aeropuerto post-Túnel	∼25 min
Pico y placa	**No aplica**

Ventaja clave

Edificio existente = no construcción. Negociación + fit-out (18–24 meses). **Apertura: H1 2028**

Score MCDA desglosado

- **Accesibilidad 85:** 18.5 min a HPTU, acceso Túnel, sin pico y placa
- **Demanda 91:** captación dual El Poblado + Oriente + aeropuerto
- **Competencia 65:** 45 facilities en 5 km, pero brecha ambulatoria
- **Visibilidad 78:** 42K veh/día, reconocimiento de marca
- **Esperas Prod. 55:** potencial anchor hospital + retail

Demanda dual: 135K El Poblado E5/E6 + 298K Oriente cercano + 14.5M pasajeros aeropuerto. 728K región (298K catchment directo)

Competencia local: 4 centros a menos de 3 km de Access Point

Centro	Dist.	Amenaza	Qué ofrece
Torre Méd. Oviedo	2.65 km	**DIRECTA**	87 consultorios, 6 quirófanos amb., CEDIMED
Cl. Rosario Tesoro	0.93 km	**ALTA**	158 camas, oncología, chequeo ejecutivo
BlueCare	1.46 km	MEDIA	Centro ambulatorio especializado
Cl. Las Vegas	3.12 km	MEDIA	171 camas, emergencias, especialidades

La realidad

AP tiene **45 facilities** de salud en radio 5 km. Competencia LOCAL es densa. Score Competencia (65/100) refleja esto.

La diferenciación

Ninguno ofrece:

- Marca **JCI** (único en Antioquia)
- Portafolio integrado **7 categorías**
- Captación del **Oriente** (298K hab)
- Heritage **55+ años HPTU**

Fuente: Google Places API, OSM Overpass, REPS (b4dp-ximh)

Competidores: la ventana se cierra

Institución	Ubicación	Inversión	Movimiento
Cl. Campestre	Rionegro	$30,000M	Sede ambulatoria mar 2026 (250 pac/día)
SVF Rionegro	Rionegro	>$200,000M	Expansión a 500 camas, helipuerto
Torre Oviedo	El Poblado	$100,000M	87 consultorios, 6 quirófanos amb. (jun 2025)
AUNA Sur	Envigado	$90,000M	168 camas, alta complej. (2024)

Urgencia

Campestre ya está en el Oriente (primer mover ambulatorio premium). Si HPTU no ocupa el nodo Las Palmas/Túnel, **otro lo hará**.

Diferenciación HPTU

- **JCI** — único en Antioquia
- **Heritage de marca** — 55+ años
- **Portafolio** más amplio (7 cat.)
- **PRENUVO** — diferenciador único

SVF: inpatient (500 camas, UCI, trasplantes) $\neq$ **HPTU ambulatoria:** outpatient (imágenes, consulta, cirugía día, wellness) $\rightarrow$ Modelos que se **complementan**.

Lo que NO sabemos (aún)

Pregunta abierta	Status	Próximo paso
¿Acierto Inmobiliario quiere inquilino médico?	Pendiente	Reunión exploratoria — abril 2026
¿Edificio soporta MRI (15 ton) y quirófanos?	Pendiente	Inspección estructural
¿SURA contrataría la sede ambulatoria?	Pendiente	Sondeo con dirección de red
¿Pacientes elegirían Km 7 sobre opciones locales?	Pendiente	Encuestas de intención
¿Túnel 2da etapa llega en H2 2027?	Riesgo	Monitoreo trimestral ANI
¿Estratos Oriente son dato real o proxy?	Parcial	Solicitar datos a alcaldías

La recomendación se sostiene — con condiciones

AP es la recomendación: **edificio existente** (18–24 meses) + **298K hab Oriente**. Condicionada a: (1) factibilidad estructural, (2) acuerdo con Acierto Inmobiliario, (3) pre-acuerdo aseguradora.

Transparencia: presentamos lo que sabemos y lo que no. Toda inversión tiene supuestos — estos son los nuestros.

Próximos pasos

1. **Visita técnica a Access Point** — condiciones físicas, accesos, entorno
2. **Verificación POT del predio** — ficha normativa, uso dotacional salud
3. **Negociación con Acierto Inmobiliario** — condiciones, plazos, personalización
4. **Modelo financiero detallado** — flujo de caja, TIR, punto de equilibrio
5. **Due diligence legal** — titularidad, gravámenes, licencias
6. **Estudio de demanda primario** — encuestas, entrevistas con aseguradoras

Timeline estimado: pasos 1-3 en abril, pasos 4-6 en mayo-junio.

Síntesis: por qué Access Point, por qué ambulatorio

¿Por qué Access Point?

Único nodo puente Poblado–Oriente. 42K veh/día. ∼25' aeropuerto post-Túnel. Score MCDA 78/100.

¿Por qué ambulatorio?

Complementa Somer+SVF. Márgenes >2× inpatient. Heritage HPTU. JCI. Sin urgencias ni UCI.

¿Por qué ahora?

Campestre ya abrió. Túnel H2 2027. Edificio existente = 18–24 meses. Apertura: H1 2028.

Recomendación: sede ambulatoria HPTU en Access Point, Km 7 Vía Las Palmas

¿Por qué no El Poblado? Ya tiene Torre Oviedo, Rosario Tesoro, CEDIMED, BlueCare. Competencia ambulatoria **densa**. AP captura **ambos mercados**: Poblado + 298K Oriente.

Plan de Expansión HPTU

Sede Ambulatoria en Access Point

MCDA 78/100 · 5 dimensiones · 6 escenarios Monte Carlo

Apertura estimada: H1 2028 · CAPEX: COP $67,000M

Revenue: $51,000M · EBITDA: $9,200M · Payback: 6–8 años

Dashboard: hptu-localizacion.vercel.app

básica

Abril 2026